

TEMA 61



LA INTERVENCIÓN SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZAR.

LAS TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA Y VISITA DOMICILIARIA.

EL INFORME SOCIAL COMO INSTRUMENTO TÉCNICO DEL TRABAJADOR SOCIAL.

APLICACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La intervención social a nivel individual y familiar: Metodología y técnicas a utilizar.	
1.1. Metodología de la intervención social a nivel individual y familiar. 1.2.- Técnicas a utilizar en la intervención social individual y familiar.	
2.- Las técnicas de la entrevista y visita domiciliaria.	
2.1.- La entrevista en el Trabajo Social. 2.2.- La visita domiciliaria en el Trabajo Social.	
3.- El Informe Social como instrumento técnico del Trabajo Social.	
3.1.- Concepto del informe social. 3.2.- Estructura del informe social. 3.3.- Realización objetiva y ética del informe social.	
4.- Aplicación a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Madrid.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El **Trabajo Social de casos** busca orientar las intervenciones tendentes a abordar el conocimiento y la mejora de las **situaciones sociales personales o familiares.** La particularidad de esta orientación metodológica es que ese abordaje se realiza situación por situación.

Las intervenciones sociales a nivel individual y familiar son muy variadas, ya que se encuentran relacionadas con los diversos fenómenos de necesidad social y sus múltiples combinaciones: pobreza, adicciones, desempleo, carencia de vivienda, fracaso escolar, malos tratos, delincuencia, discapacidades …

El sujeto protagonista de esta estrategia es la **persona,** el individuo; y el abordaje se concentra en las **relaciones bidireccionales individuo-sociedad**. Se subraya en buena medida que el individuo, su personalidad, es el resultado de la interacción entre individuo y sociedad.

Mary Richmond fue la pionera en sistematizar este método, hablando del desarrollo de la personalidad como objetivo de la intervención.

Al subrayar que esta estrategia se aplica a las relaciones entre el individuo y la sociedad, se muestra no sólo el origen social de los problemas, sino que se reconoce el importante papel que en su resolución tienen las instituciones sociales y las interacciones con otras personas y profesionales.

Un medio fundamental será la **movilización del propio sujeto afectado** en torno a las actividades previstas en el proyecto de mejora. Dependiendo de los objetivos establecidos, la persona destinataria participará en las actividades grupales, realizará trámites, mejorará sus capacidades … Normalmente se suele mantener un contacto de seguimiento del profesional, mediante el que se valora este proceso.

Los retos profesionales en el abordaje individual se basan en unas **relaciones de calidad entre el profesional y la persona destinataria**, que permitan un análisis común acertado de la realidad, la implicación/movilización del sujeto, el acceso a los recursos …

1.- LA INTERVENCIÓN SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZAR.

1.1.- METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR.

El denominado "método de caso" designa la ayuda social que se presta a nivel individual utilizando una serie de procedimientos. Ha sido el primer método que fue sistematizado dentro de la profesión. Su aparición corresponde a la etapa de la **tecnificación de la beneficencia** que se inicia en Europa, principalmente en Inglaterra en donde se comienza a utilizar, en la asistencia a los pobres, una serie de procedimientos formalizados. Esto se da fundamentalmente en las **Sociedades de Organización de la Caridad (COS)** que luego adquirieron gran desarrollo e importancia en los Estados Unidos, no solo como forma institucionalizada de ayuda a los necesitados, sino porque las COS constituyen el ámbito en donde fue posible ir avanzando en la formalización de los procedimientos a seguir en el Trabajo Social.

Es importante recordar que el método de caso se elaboró teniendo en cuenta el **modelo clínico-terapéutico de la medicina.**

Mary Richmond establecería la configuración y metodología básica del trabajo social, señalando como sus componentes básicos **el estudio, el diagnóstico y el tratamiento**. Aunque su obra más conocida es "Diagnóstico Social" (1.917) la definición de la metodología del trabajo social de casos la plantea en una obra posterior, "¿Qué es el Trabajo Social de Casos?" (1.922): "el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio".

Si analizamos la obra de Mary Richmond resulta evidente que ella nunca consideró el "caso individual" en cuanto tal, es decir, descontextualizado de su entorno. Esta autora plantea el abordaje de los problemas individuales desde una perspectiva sociológica. Sin embargo, la influencia que, a partir de los años veinte, va adquiriendo el **psicoanálisis en los EE.UU.** también se pone de manifiesto en el trabajo social de casos, adquiriendo éste una orientación predominantemente psicologista. Los problemas del individuo se plantean en términos de desórdenes en el funcionamiento intrapsíquico –ansiedad, culpabilidad, defensas paralizantes, temas libidinosos y agresivos- que dañaban las relaciones interpersonales. Esto condujo a que en la práctica profesional se prescindiese en ocasiones de los condicionamientos del entorno familiar, vecinal y social del caso.

Desde el punto de vista práctico se otorga una gran importancia, como procedimiento operativo, a la **capacidad de relación.** Igualmente, dentro de esta orientación psicologista, se abandonan los procedimientos de la encuesta social y se adoptan otros más propios de la psicología o de la psiquiatría, de manera particular, la **entrevista.**

La depresión del año 1.929 y la crisis posterior hicieron sentir sus efectos sobre el método del caso y comienzan a tomar importancia los **factores económicos y sociales**. Los problemas producidos como consecuencia de la inseguridad económica orientaron la acción hacia la familia, más que al individuo aislado.

En 1.940 aparece el concepto de **caso psico-social**, acuñado por **Gordon Hamilton**, en su libro "Teoría y práctica del Trabajo Social de Casos". En su reflexión esta autora plantea la necesidad de vincular el trabajo social individual con los problemas generales de la política social, aunque, en la práctica, el método mantiene su preponderancia psicologista.

Terminada la Segunda Guerra Mundial el caso social individual focaliza su atención sobre una nueva problemática: la **conexión entre el "yo" y las exigencias del mundo externo. Swithun Bowers** en 1.949 plantea que el Trabajo Social de Casos es el "arte que utiliza los conocimientos aportados por la ciencia de las relaciones humanas y la práctica de los contactos sociales, con el fin de movilizar los recursos de la persona al objeto de provocar una mejor adaptación del cliente a su medio".

Durante este período la influencia psicoanalítica se va perfilando en dos modelos principales:

- El **modelo clínico-normativo (orientación diagnóstica):** aplica los principios del psicoanálisis para realizar el diagnóstico, el tratamiento y el procedimiento. Esta perspectiva se introduce a través de Anna Freud y se desarrolla en nuestra profesión a través de **Helen Perlman y Florence Hollis.**
- El **modelo de crisis (orientación funcional):** se basa en la teoría de la voluntad de Otto Rank. Este discípulo de Freud –ante la lentitud del tratamiento psicoanalítico- propone **terapias breves**, que se operacionalizaron en el Trabajo Social a través de la obra de **Virginia Robinson.**

Estas dos serán las corrientes dominantes hasta que se inicia la influencia del conductismo, fundamento del **modelo socio-conductista.** El conductismo o behavourismo se apoya en el supuesto de que todo lo que se puede conocer de una persona es su comportamiento humano, el método introspectivo es fútil e ilusorio. Los comportamientos se van a explicar desde el binomio estímulo-respuesta. Para esta escuela todo comportamiento puede ser modificado en la dirección deseada a través de las técnicas de modificación de conducta que elabora Skinner. Es también muy importante la idea de que todo comportamiento social es un comportamiento aprendido y puede ser, igualmente, modificado a través del aprendizaje.

Después de los años cincuenta, la creciente aplicación del método a la terapia familiar, con la intervención de los trabajadores sociales en equipos interdisciplinares, da lugar al llamado **modelo de comunicación-interacción** que, en los años ochenta, está fuertemente influenciado por el **enfoque sistémico.**

Tanto el **enfoque sistémico** como la **psicoterapia centrada en el cliente** de **Carl Rogers**, a finales de la década de los ochenta, dan una nueva perspectiva al método de caso. El primero contextualiza la situación del caso individual, el segundo acentúa la importancia de potenciar la acción de la misma persona para poder superar su situación.

En España el caso social individual ha tenido una menor influencia del psicoanálisis, aunque sí ha mantenido un enfoque psicosocial. En nuestro entorno, el trabajo social con casos, más que un tratamiento de la persona, ha sido un procedimiento o modo de enseñar a la gente el mejor aprovechamiento de la ayuda material, financiera, sanitaria o emocional que se le podía prestar. En otros casos se ha potenciado proporcionar una atención psicosocial a la persona y a su entorno, a fin de que esta pueda enfrentarse a situaciones problemáticas, de conflicto, crisis, desequilibrio o inadaptación social.

Según algunos de los autores clásicos en la primera etapa de formalización de este método, los componentes operativos o fases del mismo son los siguientes:

Mary Richmond	**Gordon Hamilton**	**Patricia Kane**
. La encuesta, que posibilita el diagnóstico. . El diagnóstico, que conduce al conocimiento del caso y orienta el tratamiento. . El tratamiento, cuyos pasos deben llevar a la solución del problema individual.	. El estudio. . El diagnóstico y evolución. . El tratamiento.	. El estudio de los datos presentados por el cliente cuando formula sus problemas. . Diagnóstico de los datos (naturaleza del problema y evaluación del problema en términos de lo que significa para el cliente). . Planeamiento para solucionar el problema, teniendo en cuenta los recursos del cliente y de la comunidad. . Tratamiento, en el que el cliente y el trabajador social se esfuerzan para resolver el problema.

Indicando sus aspectos sustanciales, el método de caso se articula de acuerdo al siguiente esquema operacional:

- Se parte del supuesto de que la persona potencialmente puede ser sujeto y objeto de su propio desarrollo, en consecuencia, se espera que tome alguna iniciativa para salir de su situación. En ciertas circunstancias esta iniciativa puede ser inducida, sensibilizada o motivada por el trabajador social.
- El proceso se inicia cuando alguien solicita ayuda a una institución, sea esta ayuda un servicio o una prestación con la que el demandante cree poder resolver su problema o necesidad. En algunos casos la institución, a través del trabajador social, toma la iniciativa.

- Al realizarse esta entrevista de solicitud el usuario expone el problema (o lo que él cree o siente que es su problema) y el trabajador social toma la información, elabora una ficha, documento o expediente según el caso. En algunas instituciones existen formularios a este efecto.
- Desde esta primera fase es importante establecer una relación/comunicación adecuada con el usuario, la que comporta dos cuestiones fundamentales: revelar el verdadero interés de la persona y garantizar el secreto profesional.
- Se estimula al sujeto/usuario para analizar su situación y reconocer su problema, pero, sobre todo, para que tome la iniciativa de cara a resolverlo, o a comenzar a hacer algo para resolverlo.
- Esta entrevista-solicitud no sólo ha de servir para que la persona exponga su problema, en algunos casos, ya puede comenzar el tratamiento del caso y orientarlo en la resolución del mismo.
- El tratamiento o seguimiento del caso puede ser muy variado, de acuerdo al problema o necesidad y a las características del usuario. Puede exigir tanto visitas domiciliarias como que la persona siga concurriendo a los recursos o servicios.
- Dentro de la tradición de utilización de este método, suele ser siempre el mismo trabajador social el responsable de todas las actuaciones.
- Por último, como en todo tratamiento, está el fin del proceso. Se cierra el caso, ya sea porque está resuelto el problema, porque se ha llegado al límite de un período dispuesto por la institución para la intervención, o bien porque se produce un retiro gradual conforme se va resolviendo el problema o satisfaciendo una necesidad.

1.2.- TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR.

En el Trabajo Social de Casos las técnicas se aplican en un sistema de acción o intervención previamente definido y estructurado, en el que se escogen los diferentes instrumentos a utilizar, en función del diseño de intervención previamente acordado. Este diseño será continuado, dinámico, interrelacionado, no rígido o cerrado. La reflexión continua sobre la intervención y la flexibilidad son dos requisitos imprescindibles en el uso de las técnicas.

La realidad con la que trabajamos –personas, familias- es cambiante y está en constante evolución, con lo que es importante tratar de ajustar y adaptar las técnicas a cada persona y a cada circunstancia.

1.2.1.- Técnicas diagnósticas.

Las **técnicas diagnósticas** son de gran utilidad porque permiten recoger, ordenar, estructurar y representar los datos de las personas enmarcándolos en estructuras familiares o comunitarias mediante representaciones gráficas sencillas y útiles.

Genograma.

Es una técnica diagnóstica gráfica que permite condensar la información familiar en una sola imagen: la **estructura** jerárquica, las **relaciones** entre sus miembros (alianzas, coaliciones, cordialidad, aislamiento, discusiones …), la **información** de la familia que se considere más relevante (fallecimientos, desempleo, enfermedades, edad, rupturas, sucesos críticos …). Es un mapa visual que refleja la configuración de la familia, sus características biológicas y los lazos que unen entre sí a sus integrantes.

El genograma combina la información biológica, psicosocial, relacional, identifica problemas o sucesos reseñables que han incidido en la familia y tiene un enorme valor en la elaboración del diagnóstico.

Mapa de relaciones.

Es una técnica gráfica centrada exclusivamente en la representación de las relaciones familiares establecidas entre los miembros que componen el sistema familiar. En este esquema no es necesario poner los datos personales de cada miembro, simplemente se recogen las líneas relaciones que se establecen entre cada uno de ellos.

Ecomapa.

Es una técnica perteneciente al **modelo ecológico**, donde se representa a la familia rodeada por un círculo en la parte central de la figura, añadiéndose alrededor otros círculos en los que se representan los **apoyos sociales** disponibles. Se dibujan todos los elementos que rodean a la familia y que influyen en ella: amigos, vecinos, familiares, profesionales, relaciones laborales o de ocio …

Mapa de redes.

Se representan los apoyos sociales existentes en los miembros de la familia en forma de redes concéntricas. Permite estudiar con detenimiento las redes sociales de cada miembro de la familia y establecer los posibles canales de apertura para favorecer la permeabilidad familiar.

En el primer círculo se sitúan las relaciones más intensas; en el segundo, las relaciones diarias; en el tercero, las relaciones frecuentes; en el cuarto, las relaciones esporádicas y en el quinto, los contactos escasos. Posteriormente se dividen los círculos concéntricos en porciones triangulares que representan los núcleos influyentes, por ejemplo, familia extensa, amigos, relaciones laborales, vecinos, instituciones y profesionales …

Culturograma.

Mediante esta técnica se representan gráficamente los datos culturales de una familia, permitiendo analizar las fortalezas y debilidades culturales que posee la familia. Los datos que se recogen en el culturograma se reparten en cuatro grandes áreas:

a. Comunidad: tiempo de permanencia en la comunidad, situación de legalidad, motivos del traslado.
b. Familia: hábitos saludables, lenguaje y comunicación en el hogar y en la comunidad e impacto de traumas o problemas familiares.
c. Permeabilidad: racismo y signos de discriminación y contacto con instituciones y hábitos de apertura.
d. Valores: educación y trabajo, valores familiares, mito, reglas …

Cronograma.

Esta técnica permite recoger en orden cronológico los acontecimientos más relevantes del sistema familiar. Se representan en columnas los miembros de la familia, los años y los acontecimientos vividos en la familia, con lo que se obtiene una radiografía de los principales acontecimientos de la vida familiar, tanto positivos como negativos.

Visita domiciliaria.

La técnica de la observación cobra especial importancia en la **visita domiciliaria**, ya que el contexto de la vivienda es el lugar idóneo para contrastar las hipótesis que nos hemos ido formulando.

La observación del domicilio nos permite verificar la situación real en la que se encuentra el usuario. La evaluación de la situación del usuario a partir de la visita a domicilio debe basarse en el manejo de una serie de indicadores:

. Establecer el número de habitantes que conforman el núcleo de convivencia familiar.
. Estudiar el orden y la limpieza de la casa. Una casa desestructurada puede reflejar situaciones problemáticas.
. Analizar las condiciones de la vivienda: antigüedad, humedades, grietas, salubridad, electrodomésticos, mobiliario, barreras …

En la visita a domicilio debe cuidarse especialmente el comportamiento por parte del trabajador social, ya que está entrando en el espacio propio de intimidad del usuario y su familia. El tiempo de la visita no debe ser extenso, menor que el de la entrevista en el despacho. Normalmente las visitas a domicilio estarán concertadas, aunque, si es apropiado para la intervención o necesario por alguna situación de urgencia o crisis, se puede improvisar una visita al domicilio. En este caso no se puede obligar al usuario a que permita nuestro acceso a la vivienda.

1.2.2.- Técnicas de intervención.

Las técnicas empleadas durante la intervención en Trabajo Social tienen elementos terapéuticos que serán aplicados para la consecución de fines y objetivos concretos.

Entrevista. (Se desarrolla en el siguiente apartado 2.1. del tema).

La entrevista es la técnica que se constituye como pieza angular de la intervención del trabajador social de casos, ya que todo el **proceso de apoyo** está acompañado de sucesivas entrevistas que irán reflejando el plan de intervención y el proceso de cambio diseñado.

Observación.

La observación es otra de las técnicas fundamentales en el Trabajo Social Individual, que permite recopilar una información rica y variada sobre el usuario. Es una técnica que se utiliza en los otros niveles de intervención (grupos y comunidad).

La observación requiere de un **registro de datos**, para lo cual es importante anticipar de antemano cuáles son las conductas que se quieren observar. También se puede solicitar la presencia de **otro profesional** que actuará como observador, para lo cual debemos pedir permiso al usuario antes de iniciar la intervención, ofreciendo las explicaciones oportunas y precisas para justificar la presencia del observador.

Observación de la comunicación verbal.

La comunicación verbal es analizada principalmente en el contexto de la entrevista, en la relación interpersonal establecida con el usuario. La **información verbal** es el primer eslabón del proceso de comunicación profesional.

Se debe ser muy cuidadoso con la expresión de mensajes y conocimientos, observando en la conducta verbal diferentes aspectos:

- Cuidar el saludo inicial.
- Evitar las coletillas lingüísticas, ya que su empleo reiterado hace que la calidez expositiva disminuya.
- Saber respetar los silencios ya que son necesarios y también transmiten información. Los silencios dan pausa a la exposición, marcan los ritmos de la comunicación y ofrecen una sensación de tranquilidad y seguridad.
- Cuidar la exposición, que debe ser fluida y continua, coherente con su significado y adaptada a la necesidad del entrevistado y al ritmo de la entrevista.

Observación de la comunicación analógica.

Es fundamental observar la conducta no verbal del usuario. El trabajador social escuchará atentamente el mensaje transmitido por el entrevistado mediante la comunicación verbal, pero también contrastará, mediante la observación de la conducta no verbal, el contenido del mismo. La conducta no verbal –o analógica- es espontánea, casi inconsciente y aporta información muy valiosa.

Cuando hablamos de **lenguaje analógico**, nos referimos a diversos elementos:

- **El lenguaje paralingüístico:** es el material relativo a la entonación, la vocalización, el timbre de voz, la modulación, la fluidez …
- **El lenguaje quinésico:** alude a los movimientos corporales, la mirada, la disposición del cuerpo, el aspecto de la persona, su expresión …
- **El lenguaje proxémico:** establece la distancia interpersonal y la ubicación de las personas en el espacio. El profesional debe conocer y respetar las distancias para no intimidad o aturdir al usuario.

1.2.3.- Técnicas de evaluación.

Estas técnicas están enfocadas para evaluar las actuaciones que desarrolla el trabajador social en este nivel de intervención. Pueden ser empleadas para establecer la línea base de la situación inicial o punto de partida, además permiten realizar revisiones en las posibles modificaciones de la intervención y, finalmente, evaluar la intervención final.

Entrevista estructurada, semi-estructurada y abierta.

Las entrevistas que tienen como finalidad la evaluación, deben tener una **estructuración lógica**. Dependiendo del mayor o menor grado de estructuración se dividen en entrevistas estructuradas o directivas, semi-estructuradas y abiertas, que son las que tienen menor estructuración.

- Las **entrevistas estructuradas** tienen una composición muy cerrada. Ofrece al trabajador social la iniciativa de fijar de antemano las preguntas, lo cual disminuye el grado de libertad de expresión por parte del entrevistado.
- Las **entrevistas semi-estructuradas** son un poco menos que las estructuradas.
- En las **entrevistas abiertas** se fija un guión de temas o cuestiones a tratar. El protagonista en esta entrevista es el entrevistado, al que se le animará en sus exposiciones a recabar la máxima información posible. La función del entrevistador será incentivar a que hable del tema tratado, reorientarle cuando se desvíe del mismo e intentar conseguir un discurso que permita hacer una evaluación en profundidad.

Cuestionarios, test y escalas.

Son especialmente recomendables cuando el profesional necesita evaluar variables concretas. El trabajador social tiene dos opciones: elaborar sus propios cuestionarios de evaluación o utilizar test o escalas disponibles, que gozan de fiabilidad y validez.

- En el primer caso el profesional debe estar bien informado del tema que quiere estudiar, así podrá disponer qué aspectos e ítems deberá incluir en el cuestionario. Es aconsejable realizar una revisión bibliográfica de la materia elegida.
- En el segundo caso el profesional podrá realizar una búsqueda bibliográfica y seleccionar entre test y escalas que ya están elaboradas.

Documentación biográfica.

La documentación biográfica puede ser interesante para estudiar las vivencias de una persona o familia en alguna etapa o a lo largo del ciclo vital. Podemos diferenciar, en estos documentos, entre:

- **Documentos personales:** son registros escritos por propia iniciativa del autor. Podemos destacar la biografía o trayectoria vital de una persona contada por un tercero, y la autobiografía que es la biografía relatada por el propio protagonista.
  Las autobiografías pueden tener diversos formatos: memorias (se resaltan acontecimientos de la vida del autor), confesiones (aspectos reservados), apologías (justificar determinados hechos), espistolarios (cartas en las que se relatan aspectos de la vida de las personas) o diarios (registro continuado de sucesos e impresiones).
- **Historias de vida:** son registros motivados y solicitados por el profesional, que demanda la exposición de los hechos, sus interpretaciones y establece una estructuración temática para guiar su colaboración.
- **Biogramas:** son registros biográficos centrados en determinados aspectos que han sido extraídos de una numerosa muestra de biografías solicitada por el investigador a efectos comparativos.

Autorregistros.

Es una técnica que permite recopilar información muy específica (frecuencia, períodos, causas, consecuencias …) relativa a un tema o un asunto muy concreto, que puede ser una conducta, un pensamiento, un sentimiento … o cualquier elemento que el profesional estime adecuado estudiar para la intervención.

Esa información suele aparecer en hojas de registro específicas donde se anotan los días de la semana, las horas del día y se contabiliza la frecuencia y los elementos que se hayan planificado previamente.

1.2.4.- El asesoramiento.

La intervención del trabajador social es una actividad de **apoyo profesional** en la que es frecuente utilizar el **asesoramiento** para poder facilitar seguridad, motivar al cambio, mitigar la ansiedad, interpretar y recontextualizar la situación o movilizar los diferentes recursos.

Es una técnica profesional de apoyo y orientación, que implica apoyar a la persona a analizar su situación, sus potencialidades, sus capacidades …

Dentro de las funciones del asesoramiento, podemos destacar las siguientes:

. Conocimiento de sí mismo.
. Aumento de la confianza y la seguridad.
. Reducción de la ansiedad.
. Preparación para los cambios.
. Mejora de la autoestima y de la capacidad para tomar decisiones.
. Adaptación del usuario a la situación.
. Ampliación del abanico de posibilidades y potencialidades.
. Disminución de sentimientos negativos como soledad o abandono.
. Modificación de las percepciones y emociones del sujeto.
. Desarrollo de las potencialidades de la persona.
. Movilización de medios de apoyo.

Algunos autores proponen tres tipos de orientaciones dentro de la técnica del asesoramiento:

- **Orientación directiva:** se caracteriza por el uso de preguntas directas, con el fin de delimitar y estudiar la situación-problema. El profesional marca la intervención, compaginando este rol directivo con el principio fundamental de autodeterminación y respeto a la persona.
- **Orientación no directiva:** el eje central es la persona, no tanto el problema o la necesidad. El usuario aparece como el principal motor del cambio.
- **Orientación ecléctica:** consiste en la combinación de las dos orientaciones anteriores.

1.2.5.- El contrato.

El fin de la utilización de "contratos" en la intervención individual es **propiciar cambios en la conducta**, llegando a acuerdos entre las personas que están relacionadas con esa situación. Estos contratos son un documento escrito en el que se escriben de manera explícita las acciones que el sujeto debe realizar y establece las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de las mismas.

Los términos del contrato deben ser elaborados teniendo en cuenta las propuestas de los participantes, llegando a un contenido final con el que deben estar de acuerdo las partes implicadas para proceder a su firma.

Hay que tener en cuenta varias premisas:

- Las partes implicadas deben llegar a un consenso.
- Se deben especificar las consecuencias positivas o privilegios contingentes con lo acordado, según el criterio establecido.
- Se especificarán las penalizaciones o consecuencias negativas del incumplimiento.
- Se delimitarán una serie de bonificaciones adicionales si la persona cumple con creces lo acordado.

El contrato realizado por el trabajador social no tiene fines terapéuticos específicos no está orientado al tratamiento de patologías concretas. En la relación que se establece el trabajador social y el usuario el contrato puede afianzar los lazos profesionales, ayuda a organizar el plan de intervención, afianza la confianza y motivación del usuario, marca una temporalización o sucesión de procesos, mejora la comunicación evitando malos entendidos, afianza el compromiso para el cambio, da seguridad en relación a las consecuencias del comportamiento …

Cristina De Robertis propone las siguientes fases para la construcción de un contrato:

- **Fase preliminar:** tiene lugar la toma de contacto, las primeras premisas de la intervención. Es una etapa de conocimiento mutuo en el que se exploran las expectativas recíprocas, se establece un clima de confianza, se analizan las capacidades y recursos del usuario.
- **Fase de negociación:** implica una construcción en común, donde todas las partes aportan sus intereses. Esta fase tiene cuatro momentos importantes:
  - Clarificación de problemas y aspiraciones.
  - Establecimiento de objetivos comunes.
  - Elaboración de un plan de trabajo.
  - Formalización de un contrato.

- **Fase de puesta en marcha de los compromisos:**
  - Reparto de tareas.
  - Acompañamiento.
  - Reajuste del contrato, si fuera pertinente.
- **Fase de evaluación de los resultados:** una de las principales ventajas del contrato es que permite una evaluación más objetiva de la intervención, ya que consiste en un análisis o balance de los pactos y de los compromisos establecidos y ejecutados.

2.- LAS TÉCNICAS DE ENTREVISTA Y VISITA DOMICILIARIA.

2.1.- LA ENTREVISTA EN EL TRABAJO SOCIAL.

La entrevista constituye una de las técnicas básicas del Trabajo Social. Esta técnica adquiere una relevancia singular que comparte con otras disciplinas humanísticas o sociales, como la sociología, la pedagogía o la psicología, en cuanto ciencias o saberes que, de una forma u otra, afrontan problemas relativos a la intercomunicación e interacción humana.

Teresa Rosell destaca la importancia de la entrevista en el Trabajo Social como **instrumento para promocionar la ciudadanía.** Las personas que se hallan en situación de desigualdad –ancianos, enfermos mentales, personas sin hogar …- sufren un "exceso de identidad" al ser tenidos en cuenta, principalmente, como un problema para la sociedad, más que por sus características personales. El "problema" que presentan se convierte en su identidad, quedando muy limitadas las posibilidades de disfrutar de un verdadero reconocimiento como ciudadanos.

A través de la entrevista en Trabajo Social estos derechos pueden ser reconocidos y potenciados, o desatendidos y negados. En todo acto humano, también en el trabajo profesional como acto consciente e intencionado, se transmiten y potencian actitudes y valores de diferente índole. En la atención social puede potenciarse la dependencia o la independencia, la sumisión o la asertividad, la asunción de responsabilidades o la pasividad. En la entrevista se manifiesta la capacidad del profesional para contener las ansiedades del usuario, para ayudarle a expresar sus dificultades, poner límites … y reconocerle como persona en necesidad para ayudarle a movilizar sus propias capacidades.

2.1.1.- La entrevista en el Trabajo Social.

Diversos autores, de orientaciones y escuelas diferentes, han establecido numerosas definiciones sobre este concepto. **Rogers** plantea la entrevista como un artificio destinado a estimular el intercambio emocional en el que el consultor ayuda al cliente a descubrir y dominar sus propios sentimientos.

No podemos dejar de destacar a **Mary Richmond** como la primera autora que logra sistematizar la intervención profesional, en este caso dentro del Trabajo Social de Casos. Tras quince años de investigación e intervención social elabora una de sus principales obras, **"Caso Social Individual".** La intervención individual es, para esta autora, un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, y que pretenden ajustar al individuo en su medio social. El Trabajo Social Individual *"se ocupa de las cuestiones relativas a la restauración de la independencia económica, individual, a la salud y a la higiene personal, así como los problemas complejos de higiene mental, todos terrenos que tienen una relación directa con la personalidad"*.

La entrevista va a ser el principal instrumento que tendrá el trabajador social en cada uno de las fases de la estructura metodológica que propone: el **estudio** (o encuesta o investigación), donde se recolectarán datos referidos a la conducta personal del individuo; el **diagnóstico**, donde se logra la comprensión de la individualidad y sus características personales y el **tratamiento**, donde se identifican los pasos a seguir para solucionar el problema individual.

Teresa Rosell define la entrevista en Trabajo Social como **una entrevista abierta que tiene como objetivo primordial la consecución de un conocimiento psicosocial del usuario que posibilite la intervención posterior.** Este proceso puede extenderse desde el mero asesoramiento sobre recursos sociales hasta la estimulación de las capacidades personales.

La entrevista se convierte, por tanto, en instrumento de estudio y de intervención. La entrevista se constituye como un proceso, como una técnica y como una relación.

- **Como relación** implica el contacto interpersonal entre el trabajador social y el usuario o persona que accede al servicio. Este tipo de interacción tendrá unas connotaciones profesionales diferentes a las que el usuario pueda establecer en su vida personal con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo …

- **Como técnica** es la utilización consciente e intencionada de conocimientos, procedentes de la teoría, de la experiencia y de otras fuentes de información, que el trabajador social transforma en conducta mediante la relación que establece con el cliente.

  Para esta autora, la psicología aplicada a la entrevista en el Trabajo Social, va a destacar los siguientes aspectos:

  . El objetivo es la atención de necesidades psicosociales de la población.
  . El estudio y la observación de los aspectos psicológicos en relación con el estudio de la situación social.
  . El diagnóstico hace referencia a los aspectos psicosociales, no a los aspectos psicopatológicos.
  . El tratamiento de los aspectos psicológicos en el Trabajo Social va unido a la prestación de recursos sociales.
  . El nivel de formación, que delimita su campo de actuación.

- **Como proceso** la entrevista estará delimitada por diversas fases, que constituyen parte del proceso de seguimiento de un caso.

María José Escartín plantea que la entrevista va a ser un medio fundamental del que se va a valer el trabajador social, estableciéndose procesos de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. La entrevista es un tipo de relación interpersonal o interacción, donde la comunicación guiará el proceso de ayuda.

Manuel Moix define la entrevista como el medio usual, en la práctica, de entrar en contacto con alguien y de establecer una relación con él. Su fin es despertar la posibilidad de autoayuda en el usuario y restaurar su capacidad de autosostenimiento, manteniendo de este modo el respeto a sí mismo y su dignidad. En el desarrollo de las entrevistas es donde el trabajador social expondrá su técnica y los conocimientos adquiridos como profesional.

Concluyendo, podemos afirmar que la entrevista en el Trabajo Social de casos es un recurso profesional imprescindible que permite el establecimiento de una relación interpersonal entre el trabajador social y el usuario, con el consecuente intercambio de información que se deriva del propio proceso de interacción entre ambas partes.

Definición.	Técnica fundamental empleada en el ejercicio profesional del trabajador social con casos, cuyo objetivo primordial es observar y analizar la demanda planteada del usuario, para seguidamente integrar todo ese contenido informativo en el plan de intervención de la acción social, que intentará facilitar las capacidades y el desarrollo integral de la persona, persiguiendo en última instancia el bienestar del entrevistado.
Características fundamentales.	• Implica una relación interpersonal profesional. • Es una fuente básica de recopilación de información u de análisis sobre el desarrollo de la intervención. • Es una herramienta para favorecer el apoyo y la intervención técnica del trabajador social.

	• Es el lugar donde se proyectan las teorías y el conocimiento del trabajador social. • Es un motor y motivador de cambio.

Como es sabido, la entrevista se va a caracterizar:

- Por realizarse verbalmente.
- Por ser asimétrica.
- Por basarse en un clima de comprensión mutua.

2.1.2.- Tipologías de entrevista.

La entrevista va a adquirir diferentes formas y contenidos en función de los objetivos marcados en la intervención del trabajador social, del momento temporal en el que nos encontremos y del contexto personal o institucional. No existe una entrevista única y exclusiva para el Trabajo Social.

Tipologías clásicas.

Recogemos la siguiente tipología, recogida por Escartín, Palomares y Suárez:

Según los **objetivos**:

- Informativa.
- De orientación y uso de recursos.
- De derivación.
- De atención a demandas puntuales.
- De recogida de datos o estudios socio individuales y familiares.
- De relación, seguimiento y tratamiento.

Según el **número de entrevistados**:

- Individual.
- Grupal.
- Familiar.

Según el **marco teórico**:

- Entrevista sistémica.
- Entrevista psicosocial-psicodinámica.
- Entrevista conductual.
- Entrevista fenomenológica.

Según el **estilo de asesoramiento**:

- Directivas.
- No directivas.

Según el **momento de la intervención**:

- **Entrevista preliminar**: presentación, casos rápidos y urgentes, entrevistas de derivación.
- **Primera entrevista**: establecimiento de la relación, esclarecimiento de objetivos.
- **Entrevista de seguimiento o tratamiento**: con distintas técnicas de asesoramiento.
- **Entrevista final**, de terminación.

De esta clasificación hay que destacar –por su importancia en la intervención-, la importancia que tienen la primera entrevista y la entrevista final.

- En la primera entrevista, el trabajador social deberá ser especialmente cuidadoso, porque de ella depende buena parte del éxito de la intervención profesional. Es fundamental establecer una buena relación interpersonal sobre la que ejercer la destreza profesional. En el primer contacto con el usuario, éste puede mostrarse cohibido, ansioso, desorientado, puede que no sea capaz de mostrar con sinceridad y claridad su situación. En este contexto de incertidumbre, ansiedad y temor el trabajador social debe lograr la confianza y la autenticidad, elementos indispensables para la relación profesional.

Algunas indicaciones importantes a tener en cuenta en la primera entrevista son:

- Ser cuidadosos con el saludo y la presentación inicial, sin caer en un excesivo formalismo, pero sin ser excesivamente amigable.
- Esperar a que el usuario tome la iniciativa en la exposición del motivo de su visita; si no lo toma, lo hará el profesional.
- Mostrar interés por el usuario y que él lo perciba. Hay que evitar todas las interrupciones.
- Observar si la persona se siente cómoda con la presencia del profesional y si el contexto es adecuado para el desarrollo de la entrevista. Se cuidará el entorno del despacho para que éste sea acogedor.
- No agobiar al usuario, se intentará seguir el ritmo que marque el usuario.
- Mostrarse seguros y profesionales. Hablar despacio y claro, sin vacilaciones ni ambigüedades.
- Observar al usuario, sin que se dé cuenta de que es observado.
- Delimitar la intervención futura para asegurar la implicación de la persona.

- Con la entrevista final concluye el tratamiento social. Al igual que preparamos el inicio, debemos preparar el final. Puede haber reticencias por parte del usuario principalmente ante la resolución y terminación de la intervención, con lo que se pondrá especial atención para que la despedida no sea un hecho traumático para el usuario. No se debe fomentar la dependencia, sino insistir al usuario en la capacidad que por sí mismo tiene para hacer frente a sus problemáticas.

La entrevista con intérprete.

En el Trabajo Social con refugiados, inmigrantes … es imprescindible recurrir a los intérpretes, dando lugar a entrevistas que presentan mayor dificultad, porque la comunicación directa entre el trabajador social y el cliente tiene que establecerse a través de una tercera persona que hace de intérprete.

La presencia de esta tercera persona se hace también necesaria en el caso de ciertas discapacidades, como, por ejemplo, los sordomudos, cuyo lenguaje de signos debe conocer un especialista.

El intérprete nos ayuda a resolver los problemas que pueden surgir cuando los participantes no comparten el mismo idioma, ni la misma cultura, ni las mismas posibilidades de comunicación. Un intérprete hábil y bien entrenado puede proporcionar el puente necesario entre el trabajador social y el usuario, tanto en la comunicación verbal como en la no verbal.

Las dificultades en este tipo de entrevista aumentan cuando se dan alguna de las siguientes circunstancias:

- Excesiva identificación entre el cliente y el intérprete.
- Excesiva identificación entre el intérprete y el trabajador social.
- Predominio del intérprete.
- Su rechazo por parte del cliente.

- Comprensión distorsionada y falseada de las acciones, sentimientos y pensamientos de los presentes.

- Entendimiento verbal restringido o bloqueado, pese a la buena relación emotivo-cultural.
- Relación emotivo-cultural restringida y bloqueada, a pesar del buen entendimiento verbal.

2.1.3.- Fases de la entrevista.

Antes de realizar una entrevista, el trabajador social debe preparar o retomar la intervención. Para ello se cuenta con unas herramientas indispensables: la ficha social y el informe social, donde se registra toda la información pertinente de la situación social tratada.

Este material permite la preparación de las futuras entrevistas con el usuario.

Se suele plantear que la entrevista se estructura en tres fases:

1. **Fase de enlace y presentación.** Consiste en el saludo inicial. Se debe realizar la conexión con la intervención desarrollada en sesiones anteriores. Para ello es importante retomar el material visto en la última entrevista. Este proceso facilita que la persona aprecie nuestro interés y que se implique en la intervención. Se intenta crear un clima agradable, no dedicando más de 10 minutos a esta parte, aunque siempre debemos adaptar su duración a la situación específica.
2. **Fase de desarrollo.** Es la parte en la que se presenta la intervención programada. Se exponen los objetivos marcados y la intervención que se ha diseñado previamente. Es una fase simultánea de observación y actuación, ya que en ella se pueden elaborar y contrastar las hipótesis de trabajo.
3. **Fase final y de enlace.** Debemos ser cuidadosos con la despedida, para poder ir preparando el enlace y la presentación de la siguiente entrevista. En esta fase se hará un repaso final de lo comentado, solucionando las dudas planteadas y delimitando los compromisos y actuaciones a realizar, tanto por el trabajador social como por el usuario.

La duración de todas estas fases no debe exceder de una hora y media. Pasado este tiempo, tanto el usuario como el trabajador social presentarían síntomas de agotamiento. El tiempo idóneo estimado es de 45 a 60 minutos en total.

La entrevista comienza y acaba con el enlace, porque es fundamental establecer una continuidad a las entrevistas.

2.1.4.- Técnicas que se emplean en la entrevista.

Las preguntas.

La preparación y formulación de las preguntas que han de hacerse tiene una gran importancia para el éxito de una buena entrevista. La mayoría de los autores coinciden en destacar que, antes de hacer una pregunta, nos tiene que interesar su respuesta.

Pamela Trevithick realiza la distinción entre las preguntas abiertas, las cerradas, las preguntas ¿qué? y las preguntas circulares.

Preguntas abiertas.	Son las dirigidas a fomentar en los clientes la libertad de expresión y la exteriorización de sus pensamientos y sentimientos con sus propias palabras y cuando lo juzguen conveniente. Una serie de preguntas de este tipo es, con frecuencia, muy conveniente al empezar la entrevista para obtener las informaciones de carácter general que el trabajador social necesita. Puesto que la entrevista inicial sirve fundamentalmente para reunir los elementos que permiten emprender el estudio del caso, la técnica consiste en hacer preguntas que

	provoquen respuestas de carga positiva, evitando las que puedan contestarse con un "sí" o con un "no".
Preguntas cerradas.	Son aquellas que exigen la contestación con un "sí" o con un "no" o con respuestas esperadas –las que indagan el nombre de una persona, su domicilio, edad ...-. Son preguntas útiles para obtener información objetiva o detallada, sobre todo si hay un límite de tiempo. Pueden emplearse también para centrar la entrevista, abrir áreas nuevas, cambiar el ritmo de la entrevista, apartarse de temas delicados o emotivos, o por el contrario, aproximarse a ellos. Presuponen mayor preparación y responsabilidad en el entrevistador. Son valiosas cuando se trabaja con personas que no tienen mucha confianza en sí mismas, o que desconocen el idioma, o que tienen dificultades importantes.
Preguntas "¿qué?".	Se suelen utilizar en la terapia familiar y en otros tipos de terapia breve. Su principal ventaja es su imprecisión, pues el "¿qué?" explícito en la entrevista deja al entrevistado la libertad de definir los temas o cuestiones en los que desee explayarse. Otra ventaja es que pone el énfasis en el presente más que en el pasado, sin cerrar la posibilidad de hacer preguntas relacionadas con este último si se considera necesario. Se trata de preguntas muy adaptables, sobre todo cuando se intenta explorar temas más amplios y el papel que otros individuos o factores puedan desempeñar en relación con ellos.
Preguntas circulares.	Se emplean sobre todo en la terapia familiar. Se trata de interrogaciones importantes que sirven para recoger información y destacar las diferencias entre los diversos miembros de la familia, y como estas personas se relacionan entre sí o se enfrentan con una cuestión determinada. Para ello, se pide a cada uno de los integrantes de la familia o del grupo que haga comentarios sobre el comportamiento, actitud u opinión de los otros miembros, tratando de poner de relieve la "causalidad circular", es decir, la influencia recíproca que ciertas conductas ejercen en cada uno de ellos.

Técnicas verbales en la entrevista.

Las técnicas que permiten al profesional intervenir verbalmente durante la entrevista son muy diversas. Se diferencian por el objetivo que tratan de alcanzar y por la estructura que requieren. La clasificación más aceptada es la que las divide en función de la mayor o menor **directividad** de las mismas. De manera gráfica, podemos diferenciar:

Técnicas no directivas.	. Apoyo, sostén, orientación.

	. Clarificación: paráfrasis, verbalización, resumen. . Reflexión.
Técnicas semidirectivas.	. Exploración, interrogación. . Contraste. . Interpretación. . Información. . Ventilación.
Técnicas directivas.	. Consejo, sugerencia. . Persuasión. . Control. . Confrontación.

- Las **técnicas no directivas** son aquellas intervenciones orientadas al apoyo y a la autocomprensión de la persona, con escasa influencia del trabajador social.
- Las **técnicas semidirectivas** se orientan a la comprensión de la persona, basándose en los mensajes de ésta y en las percepciones e hipótesis del asesor. El término "semidirectivo" se introduce para diferenciar estas técnicas de las técnicas que buscan incidir de manera directa y firme en la acción y no sólo en la comprensión –técnicas directivas-.
- Las **técnicas directivas** se orientan a la confrontación y la acción. Se basan íntegramente en la percepción y el cuadro de referencia del asesor. Las intervenciones descansan sobre las hipótesis que el profesional ha ido elaborando sobre el cliente.

2.2.- LA VISITA DOMICILIARIA EN EL TRABAJO SOCIAL.

Históricamente se tiene referencia de que la visita domiciliaria habría sido una práctica habitual desde la génesis profesional del trabajo social, con la **Organización de la Caridad de Londres** en 1869, cuyo objetivo era descubrir las causas de la indigencia y planificar su solución. Otros fueron también inspiradores como Luis Vives, San Vicente de Paúl entre otros, atribuyéndole gran importancia a la entrevista en el hogar que luego debía ser trascrita. Con **Mary Richmond**, precursora norteamericana, se utilizó la técnica de realizar **"visitas amistosas" ("friendly visitors")**, a los necesitados. En 1917 plantea en su libro "Social Diagnosis", la necesidad de estudiar al individuo en interacción con su entorno. La visita domiciliaria fue una herramienta metodológica fundamental en la fase de estudio y valoración del caso. Esta técnica permitía un acceso a una información valiosa y propia de nuestro quehacer profesional, que no realizaban ninguno de los otros profesionales con o para los que trabajábamos (médicos, psiquiatras…).

En una compilación recogida por Cazorla y Fernández (2014) se encuentran algunas de las siguientes **definiciones** para esta técnica:

- "Técnica privativa del Servicio Social que se aplica en el domicilio del cliente, a través de la entrevista y observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular el problema del cliente al sistema socio-familiar" (Quiroz, 1998).
- "Atención proporcionada en el hogar del individuo o familia con el objeto de conocer la realidad socio-económica, ambiental y cultural, complementar el diagnóstico, estimular la participación activa de la familia, realizar intervención social con fines de fomento, protección, recuperación y rehabilitación" (Ministerio de Salud de Chile, 1993).
- "Entrevista efectuada en el domicilio del sujeto de atención para profundizar y observar el ambiente familiar, contribuye directamente a interrelacionar hechos reales facilitando la precisión del diagnóstico" (Quiroz y Salazar,1999).

- "Acto profesional que se compone de varias técnicas: la entrevista (con sus recursos específicos, subtécnicas y habilidades), y la observación en sus distintas formas (participante, estructuradas, no estructuradas, focal…)" (González, 2003).

María del Castillo Gallardo define la visita a domicilio como una práctica que desarrolla el trabajador social en los procesos de apoyo y que generalmente tiene por objetivo realizar una entrevista personalizada a la que le añaden las variables de observación del entorno residencial y de apoyos sociofamiliares. Es también fuente de contrastación para la información disponible de un caso.

Los profesores Fernández y Ponce de León lo definen como una variante de la entrevista que permite al profesional completar la valoración del caso social utilizando la información obtenida en el contexto natural del usuario, o en el lugar de residencia habitual. La información recogida utilizando esta técnica permite verificar la situación real del caso, ya que los datos facilitados en las entrevistas del despacho, pueden diferir de los recogidos en el domicilio.

Por tanto, a través de la aplicación de esta técnica buscamos el desarrollo de ciertos **elementos clave***,* que ampliando los referenciados por Cazorla y Fernández, podrían ser los siguientes*:*

1. Realización de la entrevista por el trabajador social en el domicilio del cliente/usuario y su familia.
2. Con fines de diagnóstico e intervención, pues permite conocer la realidad socio-económica, familiar, ambiental y cultural "in situ", ofreciendo al profesional un conocimiento experiencial.
3. Involucra a la familia en el diagnóstico y tratamiento del problema. Es clave en la realización del diagnóstico social y en el trabajo de acompañamiento al ciudadano para la consecución de sus objetivos de mejora y de cambio, especialmente en los casos de negligencia o incompetencia parental.
4. Permite mirar "desde los ojos del niño", su espacio y entorno más íntimo y abrir el foco de nuestra propia mirada más allá de nuestra "atalaya", profesional o despacho.

Si se tienen en cuenta las aportaciones de Valentín González Calvo (2003), tradicionalmente la visita domiciliaria se definía en torno a su objetivo fundamental, **clasificándose** en:

- **Visitas asistenciales**: aquellas pactadas con la familia para valorar la necesidad o pertinencia de un determinado bien o servicio, dicho recurso sirve para proveer o satisfacer una demanda, necesidad o expectativa del grupo familiar. Por ejemplo: servicio de ayuda a domicilio, adaptación de la bañera, etc.
- **Visitas diagnósticas y de evaluación**: a veces a demanda externa de otra institución como Comisión de Tutela del Menor o un Juzgado de Familia, con el objetivo de orientar la intervención profesional de modo coordinado, de complementar, contrastar y ampliar la información obtenida por otras vías o de ayudar a otras instancias a tomar una resolución. Por ejemplo. autorizando las salidas al entorno familiar de un menor tutelado y en guarda residencial.
- **Visita socioeducativa y/o terapéuticas**: en el que trabajar determinados contenidos, entrenamiento y adquisición de habilidades y/o capacidades, propiciar espacios de comunicación, reflexión e interacción diferentes, potenciando la resiliencia y la autogestión. Adaptando el quehacer profesional a las necesidades específicas que el caso requiera.

Sabemos que los objetivos van a marcar el contexto de trabajo y que por tanto será distinto un **contexto de ayuda** donde exista una demanda voluntaria por parte de algún miembro de la familia, pues en esos casos la presencia del trabajador social es recibida con agradecimiento y con la expectativa de que su trabajo puede aportar un beneficio directo a la familia. Mientras que en los casos de **contexto de control o coercitivo***,* donde normalmente no existe demanda directa, sino que esta ha sido realizada por un tercero o a través de una denuncia de algún tipo, la presencia del trabajador social es recibida como algo hostil, una amenaza, una intromisión en su espacio privado de alguien vivido como "un intruso que puede acarrearnos perjuicios".

3.- EL INFORME SOCIAL COMO INSTRUMENTO TÉCNICO DEL TRABAJO SOCIAL.

Durante largo tiempo el contenido del informe social ha estado sometido al criterio y subjetividad de cada profesional. El Seminario promovido por el **Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en 1.984** constató la diversidad de modelos existentes, y elaboró una propuesta que, por su calidad técnica, supuso un punto de inflexión en el avance hacia el rigor de este documento.

Desde aquel momento, en el **Ayuntamiento de Madrid**, se han realizado diversos esfuerzos orientados a mejorar este instrumento de trabajo, destacando las directrices establecidas por la entonces Área de Servicios Sociales sobre la emisión de informes a otras instituciones (1.984), los trabajos de las Jornadas sobre Documentación Técnica (1.987) que distinguen entre los informes de derivación, los informes propuesta y el informe social propiamente dicho, la adopción del informe social informatizado (1.990) o la constitución de un grupo de mejora sobre los informes sociales (1.996).

En las jornadas celebradas para la presentación de los **criterios organizativos para la mejora de la atención social (Madrid, 1.999)** se afirmaba que:

"Los principios que orientan las nuevas tendencias de la organización administrativa como gestora de los intereses del Cuerpo Social, el derecho de los ciudadanos a recibir servicios públicos de calidad, obligan a un ajuste continuo de los métodos de trabajo.
En esta apuesta por la calidad no puede quedar al margen uno de los instrumentos básicos y de mayor tradición en la práctica del Trabajo Social: el informe social".

3.1.- CONCEPTO DE INFORME SOCIAL.

El **Diccionario de la Real Academia Española** define el informe como "noticia o instrucción que se da de un negocio o suceso, o bien acerca de una persona". Se refiere también a la "acción y efecto de informar o dictaminar".

Existen en el ejercicio del Trabajo Social unos soportes documentales básicos: la Historia Social, la Ficha Social, el **Informe Social** y el Diseño de Intervención Social.

Dentro de estos soportes documentales básicos se puede entender que el de mayor importancia es el informe social, dado que en este documento describimos una situación, resumimos la historia social, identificamos el problema, transmitimos la intervención llevada a cabo, y, por lo tanto, el diseño de intervención, y finalmente establecemos el diagnóstico de la situación y elaboramos una propuesta de intervención.

Su finalidad es informar a otros profesionales o responsables de programas, servicios o instituciones externas, acerca de la situación de una persona o familia con la que intervenimos, y para la que estamos solicitando una intervención técnica específica de mayor complejidad o algún tipo de prestación específica (prestaciones económicas o materiales, ayudas para la rehabilitación de la vivienda y eliminación de barreras arquitectónicas, ayudas técnicas para la promoción de la autonomía y prevención de situaciones de dependencia, el acogimiento de un menor …).

La **elaboración del informe social** implica un esfuerzo cognitivo de interpretación, clarificación y ordenación de, en ocasiones, una cantidad ingente de datos. El informe social proporciona una oportunidad valiosísima de sistematización, depuración y ordenación de datos, con lo que incrementa la precisión del diagnóstico y la eficacia de la intervención.
Facilita la transmisión interna de los casos y evita que los profesionales tengan que "partir de cero" en sus

intervenciones.

Si se elabora a partir de procedimientos de investigación y evaluación fiables y válidos reduce la arbitrariedad. Al igual que el informe médico o psicológico parte de evidencias científicas, debe sustentarse en datos contrastados. El informe es el resultado de una investigación científica de la realidad que, por tanto, no se reduce a su mera descripción, sino a la determinación de las variables que pueden estar operando en el fenómeno social que se estudia, relacionando éstas como hipótesis susceptibles de contrastación o validación.

El **Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales** define el informe social como "la **síntesis explicativa de una situación dada, emitida por un trabajador social como resultado del estudio, valoración y dictamen, para el logro de un objetivo determinado**".

El Informe Social pretende, por tanto:

1. Dar a conocer la existencia y características de una situación social determinada con el propósito de paliarla o modificarla.
2. Aportar información para el dictamen profesional.
3. Obtener recursos sociales ya establecidos.
4. Promover recursos sociales.
5. Facilitar información a otro trabajador social.

El actual **Código Deontológico del Trabajo Social (2.012)** lo define como "**dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional**".

Ezequiel Ander-Egg lo define como "documento que facilita datos e información referentes a la situación de personas, instituciones, grupos, problemas o hechos, consignando la interpretación, opinión o juicio del trabajador social que lo emite".

Un autor español clásico, como **Manuel Moix**, lo define como "documento elaborado por el trabajador social en el que consta, en síntesis, no solo el resultado del estudio o valoración de la situación del cliente, sino también el consiguiente dictamen y la oportuna propuesta de actuación profesional".

La elaboración de este documento requiere un proceso de selección de los datos registrados en la historia social y sistematizados en la ficha social. La confección del informe, por tanto, se produce con posterioridad a determinadas intervenciones profesionales y es el resultado de tratar de ordenar la información recabada, realizando un **proceso racional de interpretación que conduce a la emisión de un juicio profesional.**

Son rasgos, por tanto, del informe social:

- La obligatoriedad de que el informe social solo puede ser efectuado por los diplomados en Trabajo Social / Asistentes Sociales, según se establece en el Código Deontológico.
- Es un **dictamen técnico** soportado en base documental que sirve como instrumento a los profesionales del Trabajo Social.
- Es una **técnica profesional** al configurarse como un dictamen técnico que es emitido conforme a criterios técnico-científicos que poseen los trabajadores sociales.
- Es el **resultado de una intervención**, con una estructura que se recoge dentro de un marco general para su elaboración.
- Tiene una finalidad: **informar de la situación** de una persona o familia desde los criterios técnicos del Trabajo Social.
- Incluye una **valoración** y una **propuesta de intervención** a otra entidad, aunque este último

apartado se puede obviar si no es ese el objeto del informe.

A diferencia de la historia social, que es una, puede haber tantos informes sociales como sean necesarios para el tratamiento y resolución del caso.

3.1.1.- Principios en el informe social.

Los **principios** por los que se debe regir la realización y la emisión de los informes sociales, vienen establecidos por los principios generales de la profesión, como se recogen en el **Código Deontológico:**

- **Derecho a la intimidad.**
- **Confidencialidad.**
- **Uso responsable de la información.**

La realización y la emisión del informe se podrán realizar siempre en un contexto profesional en las siguientes situaciones:

A iniciativa del trabajador social: tras una valoración previa, el profesional tiene que hacer efectivo el deber de informar, bien por conocimiento de una situación de riesgo, o por la necesidad de dar conocimiento a otra administración con competencia en la materia sobre la que se informa de modificaciones en la situación dada, al objeto de que se tomen las medidas oportunas o se modifiquen los recursos establecidos.

A petición de otra administración: partimos de la obligatoriedad por parte de los profesionales de realizar los informes sociales con base en la necesaria y preceptiva colaboración entre las Administraciones. En relación a los trabajadores sociales, siempre será obligatorio presentar informes cuando se trate de la Administración de Justicia o en situaciones relacionadas con la protección de los menores ("toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, L.O. 1/1.996, art. 13.1.).

En estos supuestos sólo se debe informar sobre los datos que se le soliciten por parte de los organismos públicos, y no deben recogerse datos o circunstancias que no sean relevantes para el caso.

La remisión de informes a otras Administraciones puede afectar su estructura, ya que cada vez es más frecuente la utilización de documentos propios por parte de las administraciones, estableciendo sus propios modelos de informes sociales, lo que facilita la valoración del mismo y evita al profesional tener que aportar datos innecesarios.

A petición del usuario cliente: Si el propio usuario solicita el informe social, según recoge la Guía Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, se le debe entregar, en cualquier caso.

Se recomienda que el usuario solicite el informe por escrito, motivando dicha solicitud, de forma que el trabajador social pueda confirmar que su petición es lícita y acorde con el fin profesional perseguido. También podrá ser realizado el informe cuando el usuario se encuentre dentro de un proceso de intervención social.

A petición de entidades privadas: Siempre será realizado si la entidad privada tiene convenio de colaboración con el organismo para el que trabaja el profesional y la persona para la que se solicita el informe esté dentro de un proceso de intervención social.

3.1.2.- Tipos de informe según el objetivo.

La variedad de los informes que podemos realizar nos permite diferenciar entre diversos tipos de informes.

- **Informes técnicos:** no son estrictamente un informe social, ya que no reflejan la totalidad de la situación y no presentan la estructura básica de un informe social. Su objetivo está más relacionado con la solicitud o modificación de prestaciones, por ejemplo, una residencia para personas discapacitadas. En la mayoría de las prestaciones regladas las instituciones tienen sus propios modelos, recogiendo estos informes específicos.
- **Informes acreditativos:** se realizan atendiendo a un convenio entre entidades. Sirve para acreditar que una situación es cierta, para la obtención de un determinado servicio o prestación.
- **Informes de derivación o propuesta:** su objetivo es derivar al usuario o a la familia a un determinado programa o servicio.
- **Informes sociales genéricos:** el contenido de la información puede proporcionar información sobre varias situaciones, desde una solicitud de una vivienda, la concesión de una prestación o la solicitud de información por parte del propio usuario.
- **Informes sociales sobre menores:** los informes de menores en los que se proponen medidas de protección son de especial significado, debido a las consecuencias que se pueden derivar de esta propuesta.
- **Informes sociales de mayores o personas adultas en riesgo:** cada vez es más frecuente la solicitud de informes sociales en este ámbito. Su trascendencia es muy parecida a los informes ya citados en relación a los menores.

3.2.- ESTRUCTURA DEL INFORME SOCIAL.

Los datos que se aportan en un informe social deben ser los **adecuados, pertinentes y no excesivos** para la finalidad que se pretende, evitando incorporar toda la información con la que se cuenta, obtenida fundamentalmente a través de la observación y la entrevista, y que no sea relevante al objetivo para el que se emite el informe.

Si bien es importante el contenido del informe, la presentación contribuye decisivamente a la forma en que es percibido por el destinatario y, en definitiva, a su utilidad. El informe ha de ser **estructurado**, es decir, guiado por una secuencia lógica que interrelacione todos los aspectos parciales que integran la narración. La estructura en apartados del informe permite romper la monotonía del texto y evitar el desorden entre las ideas. Si el informe carece de secuencia lógica se dificulta su comprensión y desmotiva a su lectura.

En cuanto al **objetivo del informe**, la información a aportar es distinta entre los diferentes tipos de informe. El contenido de un informe para plantear medidas de protección de un menor es diferente a un informe de seguimiento de un acogimiento o un informe de derivación para un recurso de mayores.

3.2.1.- Datos de referencia o cabecera.

Estos datos identifican la institución y el profesional que emite el informe. Deben ser escuetos y explicativos, añadiendo también el motivo del informe y a quien se dirige.

El deber de identificación del profesional viene recogido en la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo Común. Además de la identificación del profesional se debe especificar la unidad de trabajo dentro del servicio.

3.2.2.- Datos de identificación de la unidad de convivencia.

Describe el núcleo de convivencia de la familia o persona objeto del informe. Es necesario recoger el nombre y apellidos de todos los miembros de la unidad familiar, además de otros datos necesarios para el profesional o entidad que recibe el informe: fecha de nacimiento, DNI, domicilio actual y teléfono.

En algunos casos es necesario incorporar a personas que, aunque no forman parte de la unidad familiar, entendida ésta como el núcleo de convivencia, pero son relevantes en la intervención, identificando si tienen grado de parentesco o no con la familia o persona sobre la que se informa.

En ocasiones, cuando la descripción de la unidad familiar es relevante para la intervención, y por lo tanto se precisa aportar información sobre ella, se puede aportar el **genograma**. El genograma es una estructura gráfica que permite dibujar un "árbol genealógico" registrando la información significativa sobre los miembros de la familia y sus relaciones. El genograma permite mostrar de una forma rápida de la información familiar y los patrones familiares establecidos, sobre todo los referidos a los vínculos y a la consanguinidad.

El uso de genograma es frecuente en los informes motivados por la intervención con menores, aunque también se puede extender en los informes relacionados con otras situaciones familiares. Permiten la representación gráfica de una constelación familiar multigeneracional, normalmente de tres generaciones.

El genograma permite una visión rápida de relaciones familiares complejas y es una rica fuente de hipótesis sobre necesidades o conflictos que podemos encontrar dentro del contexto familiar y como éstos evolucionan a través del tiempo.

3.2.3.- Fuentes para la obtención de la información.

En este apartado reflejamos, de forma ordenada, el grado de intensidad de la intervención (entrevistas realizadas, visitas domiciliarias, coordinaciones efectuadas …), el tiempo durante el cual se ha producido y los distintos servicios que han intervenido.

3.2.4.- Antecedentes del caso.

En este apartado recogemos la fase de inicio del proceso de intervención con la familia. Es determinante conocer si la demanda fue a iniciativa del usuario o bien a demanda del profesional, qué situación originó la intervención, con qué recursos complementarios se ha contado, objetivos planteados …

Este apartado plantea que para la elaboración del informe social hay que contar con otros documentos técnicos que ha utilizado el profesional: historia social, proyecto o diseño de intervención, hojas de seguimiento o de incidencias que recogen las entrevistas y coordinaciones mantenidas …

En este apartado vamos a hacer referencia a los distintos momentos por los que ha pasado el usuario o la familia a lo largo de la intervención: cómo ha evolucionado, los altibajos en la intervención, el uso adecuado o inadecuado de los recursos aplicados …

3.2.5.- Situación actual.

Este apartado es el núcleo del informe, donde se describe la situación que lo origina. Hay que recoger todas las variables que influyen, tanto en la intervención, como en la situación problema. Es imprescindible no confundir este apartado con los antecedentes del caso.

En este apartado se describen y analizan todas las áreas que se van a abordar en el plan de trabajo que se está realizando o ya se ha realizado, en función del objetivo del informe.

Las **áreas de trabajo** que se pueden plantear son muy amplias y heterogéneas.

Características del núcleo de convivencia o situación sociofamiliar.

Se describe fundamentalmente el nivel relacional de la familia, sus pautas de comunicación, el tipo de relaciones afectivas, su estilo educativo, las relaciones de dependencia, los núcleos de conflicto …

Se tomará en cuenta la **familia de origen** si es relevante en el objetivo del informe y las relaciones que la unidad familiar o la persona sobre la que estamos realizando el informe, mantiene con la familia extensa, son significativas. Haremos también referencia a la red social de la familia o de la persona, las relaciones personales del usuario y otras personas importantes dentro de sus sistemas de ayuda.

En este apartado es fundamental tener en cuenta las potencialidades de la familia o persona con la que realizamos la intervención, de esta forma tendremos en cuenta que éstos van a ser los protagonistas de todo el proceso de intervención social.

Situación económica y laboral.

El aspecto económico de una familia determina en gran medida la forma de vida, su nivel de inclusión o exclusión social. La información sobre la situación laboral de los adultos es también importante, estableciendo su trayectoria laboral y la posible percepción de prestaciones sociales o prestaciones por desempleo.

Es importante señalar los gastos fijos de la familia, sobre todo si éstos originan la percepción de algún tipo de ayuda por parte del servicio que emite el informe o de otro tipo de servicios (ejemplo: ayudas de comedor escolar, de escuela infantil …).

Situación escolar y cultural.

Un aspecto imprescindible a tener en cuenta es si existen menores en el núcleo familiar, curso escolar en que se encuentran, rendimiento escolar … Es importante también indicar si otros miembros de la familia realizan actividades formativas (ejemplo: participación en proyectos de inserción).

Situación de salud familiar.

En este ámbito hay que tener en cuenta el contenido del artículo 7.3. de la Ley de Protección de Datos de carácter personal, "Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

Habrá que valorar, en función del objeto del informe, la necesidad de recoger datos relacionados con la salud. En cualquier caso, sería conveniente que el usuario diera su consentimiento a la cesión de los mismos, en interés de una adecuada intervención y prestación de servicios por parte de la institución.

Los datos de salud deben ser avalados por un informe médico o bien, si no se tiene dicho documento, exponer que se tiene conocimiento de problemáticas de salud, aunque no podamos especificarlas o tal y como las ha expuesto el cliente.

Datos de la vivienda y de la zona de residencia.

Es importante la correcta descripción de los aspectos generales de la vivienda: tamaño, estructura, condiciones higiénicas, condiciones de habitabilidad, régimen de tenencia y si se producen situaciones de hacinamiento (menos de 10 metros cuadrados por persona), tipo de vivienda –pública o privada-, gastos que origina –letra, alquiler, gastos de comunidad …-, zona de residencia …

Al objeto de conocer la situación de la vivienda es necesaria la **visita a domicilio**.

3.2.6.- Intervención social realizada.

La descripción de la intervención no debe recoger la enumeración de las actuaciones realizadas –que ya hemos señalado en un apartado anterior-. Se trata de realizar una descripción de las diferentes hipótesis sobre las que hemos trabajado y como las hemos ido consensuando con el usuario o la familia, así como las medidas que hemos puesto en marcha y los objetivos que tratábamos de conseguir a través de la intervención.

3.2.7.- Valoración social.

El diagnóstico o **valoración social** es el resultado de ordenar las distintas variables que hemos analizado a lo largo de todo el proceso. Para su elaboración utilizamos todos los instrumentos técnicos de los que disponemos: diseño de intervención social, historia social, hojas de seguimiento, observación, entrevistas, informes de otros profesionales …, que nos van a transmitir el resultado de las actuaciones realizadas.

En el diagnóstico debemos identificar el problema y la necesidad de la persona o familia sobre la que realizamos el informe, responder al porqué de estas necesidades y hacer referencia a las acciones que la familia y la institución o el profesional han llevado a cabo. También determinaremos las prioridades de la intervención y estableceremos las estrategias para llevarlas a cabo.

El diagnóstico no debe redactarse con conceptos genéricos que informen de dificultades generales, sino que debe tender a describir la situación de la persona o la familia con la mayor claridad posible, destacando tanto los aspectos negativos, como los aspectos positivos.

3.2.8.- Propuesta de intervención.

En este último apartado describiremos las medidas a aplicar a juicio del profesional y del servicio emisor, acciones a llevar a cabo y recursos a poner en marcha, así como los beneficios que puede conllevar la propuesta realizada o los inconvenientes de no desarrollarla.

3.2.9.- Firma.

El informe social debe ir debidamente firmado por el profesional o profesionales que lo han realizado, especificando la unidad de trabajo a la que pertenecen, siendo conveniente incorporar el número de colegiado.[1]

3.3.- REALIZACIÓN OBJETIVA Y ÉTICA DEL INFORME SOCIAL.

Aunque buena parte de los elementos con los que trabajamos en nuestra profesión son subjetivos, y, por tanto, pueden ser discutibles, debemos tener en cuenta una serie de pautas generales que nos permitan asegurar la ética y la objetividad en el informe social.

- Registrar lo observado y contrastarlo mediante el trabajo en equipo o a través de otra documentación u otros informes, exponiendo cuando se realizó dicha observación, de que fuente parten los datos obtenidos o posibilitando que otros profesionales intervinientes aporten información sobre la situación o la persona por escrito.
- En el caso de que alguna parte del informe esté narrada por la propia persona o alguno de los

[1] La Ley de Colegios Profesionales dispone que *"Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente".*
La Ley 10/1.982, de creación de los colegios oficiales de Asistentes Sociales establece que *"Los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, que podrán tener el ámbito de Comunidades Autónomas, regional o provincial, integrarán en sus respectivos territorios a quienes reúnan los requisitos legales para ser considerados como Diplomados universitarios en Trabajo Social y Asistentes Sociales, siendo obligatoria para el ejercicio de la profesión la incorporación al Colegio correspondiente".*

miembros de la familia, reseñarlo con anotaciones como "según expone", "manifiesta" …

- No inventar ni presuponer ningún dato, no realizar juicios de valor ni sobre las personas ni sobre sus actos.
- El informe debe responder a un objetivo concreto y estar enmarcado dentro del diseño de intervención social o en caso de urgencia, responder a una situación de riesgo que haga preceptivo el envío del mismo.
- No se puede manipular el informe excluyendo datos relevantes en la propuesta.
- Respecto a la organización en la que el profesional presta sus servicios es deber del profesional conocer las normas sobre su realización y emisión. Será necesario elaborar un registro, tanto de entrada como de salida de los documentos de la institución. Cuando por circunstancias de urgencia un informe tenga que salir por una vía en la que no se pueda dejar constancia –por ejemplo, por fax- es conveniente enviarlo también por el sistema ordinario de registro de salida.
- En la evaluación de las unidades de análisis (individuos, familias, grupos, organizaciones, comunidades …) debemos superar el "sesgo negativista" que caracteriza a muchos informes. Hay que hacer referencia sobre todo a las potencialidades, a las posibilidades de cambio y a los recursos internos y externos que posee ese individuo, familia, grupo … y que pueden resultar aprovechables en la búsqueda de soluciones. El informe social debe hacer también referencia a los factores de crisis y a los elementos negativos que deben ser subsanados, pero difícilmente conseguiremos mejorar la situación, empoderar a la persona, elevar la autoestima o favorecer la autonomía si nos centramos únicamente en sus dificultades, carencias o problemas.
- No hay que olvidar que el informe no es un documento cerrado, la información que se recoge va a ser superada por el propio paso del tiempo. Para prolongar la actualidad del informe se pueden incorporar informes posteriores que mantengan actualizado su contenido.

Hay que garantizar el cumplimiento ético de los deberes profesionales recogidos en el **Código Deontológico**: secreto profesional, deber de confidencialidad y custodia de la información. El organismo receptor también debe cumplir unas normas éticas básicas, como no revelar el contenido del informe a terceros que no estén implicados en el caso.

Así, el **art. 44,** recoge que: "El/la profesional del trabajo social vele para que los informes realizados, a petición de su entidad o de cualquier otra organización, permanezcan sujetos al deber y al derecho general de la confidencialidad. En cualquier caso, la entidad solicitante quedará obligada a no darles difusión fuera del objetivo concreto para el que fue recabado".

3.3.1.- Aspectos formales a tener en cuenta.

El modo en que se presenta el informe es fundamental, ya que de ello va a depender en buena medida como lo percibe la persona que lo recibe. En la comunicación oral, que establecemos en los espacios directos de coordinación de los casos, los interlocutores se encuentran habitualmente cara a cara o bien hablar por vía telefónica en un tiempo simultáneo. En esta comunicación directa podemos negociar el significado de lo que hablamos en esa misma interacción: interrumpimos, preguntamos, pedimos aclaraciones, reformulamos, matizamos o expresamos disconformidad, sorpresa ante lo que se plantea.

La comunicación escrita se caracteriza porque la retroalimentación del lector no es inmediata, no se pueden solicitar aclaraciones o pedir explicaciones para entender mejor el contenido del mensaje. Esta falta de retroalimentación inmediata puede dificultar la comprensión, con lo que es imprescindible una redacción clara. Para ello es importante seguir una serie de premisas en cuanto a la redacción y presentación del informe:

- Es importante la **estructura del informe**. Es recomendable atenernos a las fases de la intervención, describiendo en primer lugar los antecedentes, después la situación actual y dentro de ella, las variables a conseguir, terminando con el diagnóstico y la propuesta.

- El informe debe ser **breve** en la medida que el caso lo permita, evitando reiterar ideas, escribiendo lo

más preciso y relevante para el objetivo del informe. El exceso de páginas desmotiva a la lectura.
- El lenguaje empleado debe ser **técnico**, no coloquial, pero si caer en un lenguaje retórico. Hay que evitar expresiones o etiquetas generalistas.
- Debemos **minimizar el uso de siglas** en la redacción del informe. Si tenemos que utilizarlas, es conveniente la primera vez acompañarlas por la denominación completa.

En relación a su redacción y presentación, podemos apuntar las siguientes recomendaciones:

- Es recomendable utilizar párrafos cortos, suficientemente separados. Hay que situarse en el lugar del destinatario.
- Hay que evitar preámbulos extensos o abusar de antecedentes, relatar aspectos secundarios o unir informes emitidos con otros fines.
- El lenguaje empleado debe ser claro y evitar el lenguaje burocratizado, el uso de tecnicismos o expresiones hechas, el lenguaje farragoso, el uso de esdrújulas y gerundios o la redacción impersonal –sustituyendo expresiones como "se entiende" por "entendemos"-.

3.3.2.- Deberes relacionados con la información confidencial.

Existen diversos artículos en el **Código Deontológico** que amparan al profesional en la realización y emisión de informes a todas aquellas entidades o personas que no estén directamente interesadas en el mismo. Así, dentro del Capítulo IV –La confidencialidad y secreto profesional- en el **art. 53** se recogen los deberes en relación con la información confidencial, estableciendo como deberes la calidad, el consentimiento, la cesión de información y la advertencia de confidencialidad, la limitación, el cumplimiento de la legislación de protección de datos …

3.3.3.- Objeciones del trabajador social a la realización y emisión del informe.

El trabajador social puede **objetar en la realización y emisión del informe** en las siguientes situaciones:

- Solicitado el informe por alguna administración cuando el objeto de la solicitud no se encuentre ajustado a la finalidad del trabajo social o la legalidad vigente.
- Comunicado al cliente/usuario de los Servicios Sociales, la correspondiente emisión del Informe Social, éste se negase a la misma.

Si la solicitud procede de la Administración de Justicia, el profesional puede objetar su realización "si tiene interés directo o indirecto en la materia que se juzga o relación de amistad o familiar con las personas implicadas en el procedimiento judicial, de sus abogados o procuradores, o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores" (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 343).

3.3.4.- Consideraciones sobre el informe social en función de la legislación.

Los informes sociales están sujetos al ordenamiento jurídico, y más concretamente, a la **Ley 39/2.015**, del Procedimiento Administrativo Común. Esta Ley establece una serie de normas relacionados con los informes, y que podemos aplicar al informe social.

- **Sobre la solicitud de los mismos por parte de la Administración:** La Administración podrá solicitar aquellos informes que sean preceptivos, y los que se consideren necesarios para resolver, concretando en la petición el extremo o extremos por los que se solicita.
- **Sobre el plazo de emisión:** Los informes serán enviados en el plazo de diez días, salvo que una disposición establezca un plazo mayor o menor. De no enviarse en este plazo se deben seguir las actuaciones, excepto en aquellos informes que sean preceptivos o determinantes para la resolución del problema.
  El informe que se emite fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente

resolución.

- **Sobre la clase de informe:** Por la obligatoriedad de su emisión, los informes pueden ser **preceptivos** –exigidos por una disposición legal expresa- o **facultativos** – cuando se consideran que son necesarios para resolver-. Atendiendo a su eficacia, la ley diferencia entre informes **vinculantes** –el órgano decisor está obligado a resolver en el sentido presupuesto del informe- o **no vinculantes** –no está obligado-. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son **facultativos y no vinculantes.**

  El carácter de no vinculantes no reduce el valor de este tipo de informes, ya que la propia Ley prevé la necesidad de motivar los actos que se separen del dictamen de los órganos consultivos. Aunque los informes sociales no vinculan –como regla general- a la Administración, merecen un crédito de veracidad ya que reflejan una apreciación cualificada, basada en la pericia y técnica del profesional que lo emite.
- **En relación a los derechos de los ciudadanos:** si los ciudadanos tienen la condición de interesados, tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado del procedimiento, a obtener copias de los documentos contenidos en ellos y a identificar a los profesionales que tramiten el procedimiento. Igualmente, los ciudadanos tienen derecho a poder exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, en relación con los informes emitidos por los profesionales.
- **En cuanto a la recogida de información:** los datos que recojan los informes deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad que se pretende. Los datos que se recojan en el centro o institución deben contar con el consentimiento expreso de los interesados, siempre que no se trate de datos especialmente protegidos por la legislación de protección de datos. Siempre es obligatorio que el centro responsable del tratamiento de datos informe a los interesados en el momento de la recogida de los mismos sobre sus derechos relativos a sus propios datos personales.
- **En cuanto al consentimiento del usuario:** el principio de consentimiento va muy unido al principio de información y permite al ciudadano ejercer el control sobre el uso de sus datos personales. La ley exige la prestación del consentimiento, aunque permite ciertas excepciones: cuando una ley así lo dispone (por ejemplo, en los procesos de protección de menores regulados en la Ley Orgánica 1/1.996 de Protección Jurídica del Menor), cuando los datos sean recogidos para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias o cuando tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.
- **En cuanto a la cesión de los datos:** los datos de carácter personal sólo pueden ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario, con el previo consentimiento del interesado. La Ley de Protección de Datos establece una serie de supuestos legales en los que no se quebraría el principio de consentimiento en el caso de ceder los datos: las cesiones a órganos jurisdiccionales o al Ministerio Fiscal, las cesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las cesiones de datos disociados (datos personales que no pueden asociarse a una persona identificada o identificable), cesiones de datos a otras Administraciones Públicas, cesiones de datos cuando una norma de rango de Ley lo establezca (por razón de trastorno psíquico, de tutela de menores, de responsabilidad penal de los menores …).
- No hay que olvidar que, en base a los informes, se adoptan decisiones que son susceptibles de impugnación ante los órganos administrativos o jurisdiccionales, y que, en ejercicio de sus derechos, los interesados pueden acceder a los archivos administrativos y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

4.- APLICACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Desde la Atención Social Primaria y Especializada, los profesionales del Trabajo Social no podemos dar respuestas estándares o estereotipadas, si queremos evitar convertirnos en meros transmisores de normas o dispensadores de recursos. El conocimiento sobre las necesidades y posibilidades del usuario surge a lo largo de las entrevistas, a lo largo de la relación profesional del trabajador social con el cliente.

Hace años que el Ayuntamiento de Madrid se ha ocupado de garantizar la calidad de los instrumentos utilizados en la Atención Social Primaria. Como indicaba el **Plan de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid**, disponemos de más indicadores, protocolos, pautas de observación y actuación … muchas de las situaciones que atiende el trabajador social en los Servicios Sociales Municipales, presentan singularidades difíciles de encajar en los esquemas o diagnósticos preestablecidos. El propio Plan nos recordaba la necesidad de compaginar el rigor en la utilización de los procedimientos con la flexibilidad que debe estar presente en las relaciones profesionales que vamos a realizar, ya que los Servicios Sociales son, ante todo, servicios "personales".

La trabajadora social en el ejercicio de la profesión ha de afrontar dilemas, asumir riesgos y plantear límites en su trabajo interdisciplinario, y límites en su relación con las personas atendidas. En los Servicios Sociales Municipales los profesionales tienen que asumir responsabilidades, a veces sin el tiempo necesario para establecer un estudio y un diagnóstico amplio, sobre el que asentar sus decisiones o enfrentarse con situaciones en las que la negación de problemas o la ausencia de demanda –por parte de los usuarios- no exime al profesional de tratar de verificar si existen dificultades o vulneración de los derechos.

En los Servicios Sociales Municipales, con frecuencia la trabajadora social se convierte en una persona significativa para muchas de las personas atendidas. La experiencia de buenas relaciones, y la experiencia de una buena y eficiente relación con la trabajadora social, tiende a transferirse a otras relaciones y a persistir, como pequeños puntos en una red de relaciones más amplia, que promueven experiencias significativas. La calidad de la comunicación, según recogía el citadol Plan, será calidad en la intervención.

En mayo de 2.018 el Ayuntamiento de Madrid realizó unas jornadas centradas en el análisis y debate sobre los Servicios Sociales en la Ciudad de Madrid, titulados, **"Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro?".** Este documento apuesta por un nuevo modelo de Servicios Sociales, en el que -entre otras "ideas clave"- afirma que la función esencial de los servicios sociales es **acompañar a las personas para que sean autónomas**, puedan tomar las decisiones adecuadas sobre sí mismas y cuenten con los apoyos y cuidados que necesitan en momentos puntuales de su vida o a lo largo de esta. Para ello actúan en ámbitos clave como el **apoyo a la autonomía de las personas**, el **cuidado, la tutela y la protección de los menores** y la **promoción de la inclusión social**.

Para realizar de modo adecuado su función, los servicios sociales **necesitan separar orgánica y funcionalmente las tareas de gestión de recursos económicos y ayudas, de aquellas dirigidas al acompañamiento y apoyo a las personas.**

El **nuevo modelo de Servicios Sociales** que se está planteando exige cambios radicales, y, algunos de éstos están muy relacionados con visibilizar y reforzar las actuaciones realizadas desde el Trabajo Social potenciando las técnicas que hemos desarrollado a lo largo de este tema.

En consecuencia, la tarea central de los servicios sociales **es articular y acompañar procesos de incorporación de personas con el riesgo de perder la autonomía, con necesidad de acompañamiento y tutelaje y en situaciones vitales difíciles**. Sus herramientas son diversas y abarcan desde diagnósticos hasta intervenciones comunitarias, pero todas comparten la **dimensión relacional como eje central.** Su actuación se nutre de los saberes de varias disciplinas como el trabajo social, la mediación social, la pedagogía social, la educción, la psicología, la sociología etc. Ejercer esta función necesita de tiempos adecuados para la intervención, ratios abarcables y control sobre determinados recursos.

La intervención social tiene **como método principal el "acompañamiento"** que requiere reciprocidad, pues la persona acompañada no juega un papel pasivo, sino que se le facilitan los medios para decidir su propio camino.

El objetivo es empoderar las personas fomentando el aprendizaje de habilidades sociales que faciliten la recuperación de las relaciones sociales, familiares o de amigos, y que permitan la inserción laboral y social; en consecuencia, **el valor relacional y la dimensión comunitaria son elementos definitorios de los servicios sociales**.

El acompañamiento se tiene que definir simultáneamente desde una **perspectiva individual** (apoyar a las personas para la autonomía en la vida diaria) **y comunitaria** (generar condiciones para la "autoprotección y autoayuda de las comunidades"). La orientación comunitaria en la ciudad de Madrid tiene especial importancia dadas las características del municipio, pues requiere una adaptación muy territorializada de la intervención.

Los procesos de acompañamiento y atención a las personas tienen que ser adaptados a la situación y necesidades de estas. En el municipio de Madrid una cuestión fundamental es la **diversificación en la atención y la necesidad de adaptar las respuestas**. Por ejemplo, hay personas que puede tener una inclusión activa por la vía del empleo, otras necesitas una activación inclusiva por otras vías, otras necesitan acciones que eviten su deterioro, etc.

En la **Carta de Servicios de los Centros Municipales de Servicios Sociales**, podemos señalar con claridad cómo se va a aplicar en algunos de sus Servicios el método de trabajo social de casos:

Información y orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social.	▪ Acoger a la persona o personas que hacen la demanda. ▪ Informar a las personas, de manera individual o en grupos dirigidos, sobre sus derechos y las prestaciones que existen y sobre los requisitos necesarios para el acceso a los mismos. ▪ Realizar la valoración inicial de la demanda de tipo individual, familiar o grupal. ▪ Detectar otras situaciones de necesidad de las personas usuarias. ▪ Orientar sobre opciones y alternativas disponibles para responder a la demanda planteada. ▪ Facilitar el acceso a otros servicios cuando proceda.
Asesoramiento social.	▪ Valorar la demanda planteada aplicando baremos y otros instrumentos de valoración, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de cada persona. ▪ Proponer alternativas de actuación según la valoración realizada y teniendo en cuenta los recursos disponibles. ▪ Ofrecer apoyo profesional en la toma de decisiones en relación con las actuaciones propuestas.

Apoyo social y seguimiento.	▪ Valorar las necesidades y problemas identificados, elaborando el correspondiente diagnóstico social. ▪ Diseñar, de acuerdo con la persona o familia, un programa de intervención para cada caso particular. ▪ Poner en marcha el programa de intervención para responder a las necesidades y problemas identificados, por medio del acompañamiento social y la asignación de servicios y recursos sociales disponibles. ▪ Establecer coordinación con otros profesionales y servicios relacionados con el programa de intervención. ▪ Proporcionar atención continuada, tanto individual como familiar y grupal, por parte de la/el trabajadora/or social evaluando periódicamente el programa de intervención.
Atención de situaciones de desprotección social.	▪ Hacer una valoración inicial del grado de riesgo y de la urgencia de la situación.
Gestión de servicios y ayudas sociales.	▪ Valorar técnicamente la situación de la persona y plantear, teniendo en cuenta su opinión, los servicios y ayudas sociales disponibles. ▪ Tramitar los servicios y ayudas sociales del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de otras Administraciones y de otras entidades de la iniciativa social, de acuerdo al programa de intervención. ▪ Proponer la concesión, cuando proceda, del servicio o ayuda municipal correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles. ▪ Realizar el seguimiento de los servicios y las ayudas sociales para asegurar su correcto uso o aplicación y su adecuación a la necesidad valorada. ▪ Apoyar técnicamente aquellos proyectos de la Iniciativa Social y/o de Entidades Privadas con los que el Ayuntamiento de Madrid ha establecido convenios de colaboración.

Bibliografía

. ABAD LÓPEZ, María Isabel; "Relevancia y repercusiones del Informe Social". En "Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Criterios organizativos para la mejora de la atención social". Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales. Madrid, 1.999.

. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales; "Dos documentos básicos en Trabajo Social". Editorial Siglo XXI. Madrid, 1.986.

. Escuela Universitaria de Trabajo Social de San Sebastián; "Manual de técnicas utilizadas en el Trabajo Social". San Sebastián, 1.990.

. SANTOS, C; "La Documentación en el Trabajo Social. El Informe Social". Cuadernos de Trabajo Social, nº 3. Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1.990.

. CÁCERES RODRÍGUEZ, Celsa y otros; "Documentos básicos en Trabajo Social". En FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás (coord..); "Fundamentos del Trabajo Social". Alianza Editorial. Madrid, 2.009.

. CHARROLDE, Javier y PARDAVILA, Balbino; "Información, documentación e informática en Servicios Sociales". Colección Intress. 1.992.

. CAZORLA BECERRA, Ketty y FERNÁNDEZ HORMAECHEA, Jemina; "Reflexiones en torno a la visita domiciliaria como técnica de trabajo social". Revista Universitaria de Trabajo Social, nº 3, 2.007. Universidad de Valparaíso.

. GONZÁLEZ CALVO, Valentín; "La visita domiciliaria, una oportunidad para el conocimiento de la dinámica relacional de la familia". Revista de Servicios Sociales y Política Social, nº 61.

. ILLESCAS TABOADA, María Isabel; "La visita domiciliaria en la protección de la infancia". "Trabajo Social Hoy", 3 cuatrimestre 2.016.

. Análisis y debate sobre los servicios sociales en la Ciudad de Madrid (Jornada de 16 de mayo de 2.018). "Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro?".
https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf

. Cartas de Servicios de los Centros de Servicios Sociales – Atención Social Primaria.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/31%20CS_Centros%20de%20Servicios%20Sociales%20ASP/Definitiva/CS_CentrosSS_ASP_10.03.2021.pdf